EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81934
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-04 15:37:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: UBERLINDA DE LAS ROS CONCHA VASQUEZ			**RUN**	: 8.066.240-8
F.Nac	: 20-01-1959	**Edad**	: 65 AÑOS, 2 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: LA NUEVA VIDA PASAJE LA LUNA 676			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 992639690		
Fecha Ingreso	: 2024-03-21	**Fecha Egreso**	: 2024-04-04 15:37:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Tromboembolismo Pulmonar. Score PESI Clase V
Neumonia Aspirativa
Bacteriuria asintomatica
Progresión ACV talamocapsular izq. ATE
Antec: DM2, HTA, ACV secuelar, Deterioro Neurocognitivo probable origen vascular.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I26-EMBOLIA PULMONAR. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina con antecedentes descritos reciente egreso del mes de febrero por Progresion AVE talamocapsular derecho quien inicia clinica caracterizada por decaimiento generalizado, somnolencia y tos humeda por lo que es traida al SU HSC donde es valorada , solicitan laboratorios donde se objetiva Leucocitosis con Neutrofilia, Parametros inflamatorios elevados , Rx torax con patron discretamente congestivo y reforzamiento de trama broncovascular no objetivando claramente foco de consolidacion sin embargo es ingresada al servicio de medicina para manejo medico.

Se recibe paciente en servicio de Hospitalizacion en medicina somnolienta sin aporte de informacion, personal de enfermeria refiere que paciente presentaba secreciones traqueales abundantes.
Se mantiene regulares condiciones generales, con aumento de parametros inflamatorios, nuevo CSB (+) a Pseudomona aeuriginosa, por lo que se escala a tazonam, ademas Angio TC tx (+) para TEP, por lo que inicia pese a riesgo neurológico por ACV, dosis de anticoagulantes plena.
Completa 1 semana de tazonam, con buena respuesta clinica y de laboratorio, mejor respuesta a rehabilitacion integral, disminuye requerimiento de O2 y apremio ventilatorio
En ultimos dias, Pcte en mejores condiciones generales. Se desteto de O2 adicional hace 2 dias , mas reactiva, refiere leve disnea al movilizarse en cama (sin desaturar), Hdn estable, cooperadora, semiorientada, responde y obedece ordenes simples
Tolero muy bien alimentacion oral ayer (por fono) se suspendio aporte por sng y se retira, manteniendo adecuada tolerancia a alimentacion vo. Ademas se traslapa anticoagulacion iniciando Dabigatran 150mg c/12 hrs bien tolerado. Queda pendiente ECO Cardiograma (se llama pero solicitan se realice diferidamente de manera ambulatoria).

POR TODO LO ANTERIOR SE DECIDE EGRESAR A HODOM PARA CONTINUAR REHABILITACION DE KINE Y FONO

INDICACIONES AL ALTA

1. ALTA A HODOM
2. REPOSO SEMISENTADA CON RESPALDO DE CAMA 30°/ PREVENCIÓN DE UPP/ CONTENCIÓN SOS.
3. RÉGIMEN VO ASISTIDO (SEGÚN INDICACIONES DE FONO)
4. KNT RESP Y MOTORA
5. SEGUIMIENTO POR FONOAUDIOLOGIA
6. INSULINA (SE AJUSTA POR CAMBIO ALIMENTACION) NPH 26 UNIDADES AM - 16 UNIDADES PM SC TITULAR SEGÚN CONTROLES HGT
7. B. IPRATROPIO 4 PUFF CADA 6HRS INH
8. FAMOTIDINA 40 MILIGRAMOS 1 cada 24 hrs. via ORAL
9. METAMIZOL AMPOLLA MILIGRAMOS / 2 MINILITROS 1 ampolla cada 8 hrs. via ENDOVENOSA, SOS DOLOR O FIEBRE
10. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. via ORAL, NOCHE
11. CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. via ORAL
12. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. via ORAL
13. DABIGATRAN ETEXILATO 150 MG COMPRIMIDO UNIDAD 1 comprimido cada 12 hrs. via ORAL
14. AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1/2 comprimido cada 24 hrs. via ORAL
15. QUETIAPINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1/2 comprimido cada 24 hrs. via ORAL, EN LA NOCHE SOS
16. POTASIO CLORURO COMPRIMIDO 600 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. via ORAL
17. INCORPORAR OTROS TRATAMIENTOS CRONICOS HABITUALES USADOS PREVIAMENTE (PREGABALINA, DONEPECILO, HALDOL)
18. **NO USAR POR RIESGO DE TRANSFORMACION HEMORRAGICA: ASPIRINA NI CLOPIDOGREL
19. CONTROLAR EXAM 48 A 72 HRS, PARA EVALUAR ELP, RCTO, PCR Y FUNCION RENAL
20. PENDIENTE ECOCARDIOGRAMA. (SE CONVERSO PERO DIJERON QUE NO PODIAN SUBIR A TOMARLO Y LO HICIERA ABULATORIO)
21. CONTROL POLI MED INTERNA (NAC COMPLICADA + TEP) Y NEUROLOGIA (ACV ISQUEMICO CON PROGRESION RECIENTE) EN 1 MES APROX (YA ESTABA EN CONTROLES NEUROLOGIA POR ACV FEB 2024)
22. CONTROLES SOS VIA URGENCIA

EXÁMENES Y RESULTADOS

SE ADJUNTAN AL ALTA

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO